

Sémiologie médicale

Observation médicale

Pr Ag. Amine Rahou
Service de médecine interne
EHU Oran

Objectifs

- Rédiger une observation médicale en respectant le plan Anamnèse-examen clinique orienté-synthèse.
- Lister les hypothèses diagnostiques compatibles avec les éléments d'orientation.

Objectifs

- Ebaucher une stratégie de prise en charge diagnostique:
 - ✓ établir une relation médecin-patient
 - ✓ Identifier le patient
 - ✓ Identifier le motif d'hospitalisation
 - ✓ Rapporter l'histoire de la maladie
 - ✓ Rédiger un examen clinique
 - ✓ Conclure l'observation médicale

Plan de la conférence

1- Généralités :

2- Les différentes étapes de l'observation :

A- Anamnèse

B- Examen clinique orienté

C- synthèse clinique

3- Hypothèses diagnostiques

Plan de la conférence

1- Généralités :

2- Les différentes étapes de l'observation :

A- Anamnèse

B- Examen clinique orienté

C- synthèse clinique

3- Hypothèses diagnostiques

Observation médicale

L'observation médicale est un outil de travail, rédigé par le médecin.

Elle permet :

- la construction du diagnostic,
- l'élaboration de la prise en charge du patient
- la transmission de l'information.

Écriture de l'observation médicale

- ◆ écrire très lisiblement;
- ◆ éviter les phrases, les abréviations, ou n'utiliser que celles qui sont communément admises et connues par tous les médecins (HTA, HIC...). Attention, certaines abréviations n'ont pas le même sens en fonction de la spécialité (BAV : bloc auriculo-ventriculaire en cardiologie, baisse d'acuité visuelle en ophtalmologie)
- ◆ faire ressortir le plan;
- ◆ éviter les approximations et les termes non médicaux :
« a priori... »

Écriture de l'observation médicale

- ◆ **ne pas noter** « absence de syndrome méningé » sans en préciser la justification (on est donc sûr d'avoir recherché ces manœuvres : pas de céphalée, pas de vomissement, pas de photo-phonophobie, pas de raideur de nuque, pas de signe de Kernig...);
- ◆ **ne pas noter** « examen des nerfs crâniens normal », mais énumérer chaque nerf crânien testé et, pour chacun d'eux, les manœuvres et les résultats.

Plan de l'observation médicale

Le plan minimal d'une observation est le suivant :



- ♦ date et identification du clinicien ;
- ♦ motif de consultation ou d'hospitalisation ;
- ♦ anamnèse systématique ;
- ♦ anamnèse orientée ;
- ♦ examen physique ;
- ♦ résultats des examens complémentaires déjà effectués : biologie, imagerie, endoscopie ou autre ;
- ♦ conclusion avec résumé et regroupement syndromique, hypothèses étiologiques argumentées, conduites à tenir diagnostique et thérapeutique.

Plan de la conférence

1- Généralités :

2- Les différentes étapes de l'observation :

A- Anamnèse

B- Examen clinique orienté

C- synthèse clinique

3- Hypothèses diagnostiques

Plan de la conférence

1- Généralités :

2- Les différentes étapes de l'observation :

A- Anamnèse

B- Examen clinique orienté

C- synthèse clinique

3- Hypothèses diagnostiques

Préliminaires

- ✓ Soyez présentable, Lavez-vous les mains
- ✓ Poser des questions faciles à comprendre
- ✓ Être poli, respectueux, attentif
- ✓ Écouter plus, parler moins, interrompre rarement
- ✓ Observer les expressions du visage et du corps
- ✓ Utiliser le langage corporel (sourire, silence, regard..)
- ✓ Ne pas imposer ses propres conceptions

Préliminaires

- ✓ Patient installé confortablement
- ✓ Le saluer par son nom
- ✓ Lui serrer la main
- ✓ L'appeler << Mr >>, << Mme »..
- ✓ Se présenter (nom, grade)
- ✓ Être en face de lui avec un bon contact Visuel
(au même niveau de regard par exemple)

Préliminaires

Préparez vos instruments :

Ayez à portée de main le matériel suivant :

- Stylo, papier.
- Stéthoscope, lampe, marteau, abaisse-langue.
- Montre.
- Dans le service : gants, diapason, doigtier, vaseline, tensiomètre, mètre ruban.

attitude adaptée



Si vous étiez à la place du malade, dans quelle position préféreriez-vous être pour parler à votre médecin ?

attitude adaptée



Durant l'examen clinique, soyez à l'aise, économisez vos vertèbres !

l'anamnèse ou l'interrogatoire est essentielle dans l'orientation du diagnostic. Elle a 2 objectifs principaux :

- partir de la « plainte » du malade et la préciser.

Les symptômes que peut rapporter le malade sont appelés **signes fonctionnels**. Ce sont **les signes subjectifs** qui traduisent l'altération de fonction d'un organe.

L'objectif est de préciser ces symptômes pour orienter le diagnostic;

- **L'anamnèse orientée :**

Elle est difficile lorsque les pathologies ne sont pas connues.

Elle consiste à poser des questions qui argumenteront les principales hypothèses.

Elle recherche d'autres SF sans lien apparent mais aussi des informations générales tels les antécédents, les facteurs de risque, les traitements...

Interrogatoire général ou systématique

Après d'avoir recueillis les données démographiques du patient (renseignements d'ordre administratif) a savoir :

- Nom, prénom
- Age, sexe (date et lieu de naissance)
- Origine et demeure
- Situation matrimoniale
- Profession
- Nombre d'enfants

Interrogatoire général ou systématique

Motif d'hospitalisation ou de consultation :

Le principal symptôme ou signe fonctionnel qui a motivé le patient a consulté.

Les symptômes qui sont au-devant de la scène.

Exemple : il s'agit de Mr M.A, âgé de 45 ans originaire et demeurant a Oran, sans profession, marié et père de 4 enfants admis pour prise en charge d'une douleur thoracique.

La confusion entre motif de consultation et diagnostic est source d'erreur médicale !

L'interrogatoire représente LA base essentielle du diagnostic.

Il demande au médecin du temps et de la disponibilité.

"Ecoutez le malade, il va donner le diagnostic"
Sir William Osler (1849-1919)

- **HDM (histoire de la maladie) :**

C'est le recueil des informations concernant l'épisode actuel.

Signes fonctionnels ayant motivé la consultation en termes médicaux.

préciser pour chacune ses caractéristiques
(développées après)

**Il n'y a pas de bonne médecine
sans une histoire claire de la maladie.**

- préciser également la chronologie avec les dates.
- si des traitements ont déjà été administrés pour ces symptômes, leur efficacité, leur durée...

Aucun examen complémentaire ne peut dispenser le médecin du temps qu'il doit prendre pour interroger un patient.

Anamnèse pour douleur thoracique : astuce OPQRSTU

L'anamnèse commence par une liste de questions visant à préciser les caractéristiques de la DT :

O Où se localise la DT ?

P Provoquer, reproduire, soulager : quelle activité provoque, reproduit, aggrave ou soulage la DT ?

Q Quand a débuté la DT ?

R iRradiation : la DT irradie-t-elle dans les épaules, les bras, la mâchoire, le dos ou l'épigastre ?

S Symptômes associés tels que sueurs, dyspnée, nausées, vomissements, malaise ou altération de l'état de conscience ?

T Type : pression, barre, brûlure, coup de poignard ?

U Un antécédent ou facteur de risque cardio-vasculaire est-il connu ?

ATCD (antécédents) :

- **ATCD (antécédents) :**

Ce sont les antécédents, les maladies dont souffre ou dont a souffert le malade

- **ATCD personnels médicaux :**

« Êtes-vous suivi pour une ou pour plusieurs maladies ?
Avez-vous déjà été hospitalisé ou avez-vous déjà consulté un médecin ? Pour quelles raisons ? »

Toujours préciser la chronologie et les dates, si possible le lieu du suivi, le nom du médecin, les traitements administrés et leur efficacité, les séquelles en cas de pathologie sévère ou à risque de guérison partielle (AVC, brûlure, IDM...).

ATCD (antécédents) :

ATCD chirurgicaux :

« Avez-vous déjà été opéré ? » Préciser alors le type d'intervention en termes chirurgicaux, la chronologie, le site anatomique, les éventuelles complications du geste opératoire.

Allergies : surtout médicamenteuses

Le patient n'est pas médecin, il ne sait pas ce qui est important à dire et ce qui l'est moins.

ATCD (antécédents) :

ATCD gynécologiques et obstétricaux :

- DDR (date des dernières règles) surtout chez la femme en âge de procréer
- mode de contraception
- Gestité : nombre de grossesses (incluant Avortements)
- Parité : nombre d'enfants (poids > 500 g ou ayant dépassé le terme de 22 semaines d'aménorrhée ou SA)

Exemple : G4P4A0

ATCD (antécédents) :

ATCD familiaux :

L'idéal est de demander au patient d'énumérer chaque personne de sa famille

(au moins au premier degré : parents, fratrie, enfants) en précisant leur âge et leurs pathologies éventuelles, et en cas de décès, l'âge et la cause.

Traitements en cours :

Préciser la galénique (comprimés, gélules, injections, etc.), la posologie et la chronologie d'introduction.

Mode de vie (MDV) ou habitus (curriculum vitæ) :

alimentation, consommation de toxiques, emploi, lieu de vie....

Facteurs de risque (FR) principaux : maladies cardiovasculaires, cancers

Tabac : quantité consommée chiffrée en paquet-année
 $PA = \text{nombre de paquets par jour} \times \text{nombre d'années de tabagisme}$.

Alcool, HTA, Diabète sucré, Dyslipidémie.

Toxiques consommés

Infections sexuellement transmissibles (IST) et vaccinations

Conditions de vie, environnement

Plan de la conférence

1- Généralités :

2- Les différentes étapes de l'observation :

A- Anamnèse

B- Examen clinique orienté

C- synthèse clinique

3- Hypothèses diagnostiques

Plan de la conférence

1- Généralités :

2- Les différentes étapes de l'observation :

A- Anamnèse

B- Examen clinique orienté

C- synthèse clinique

3- Hypothèses diagnostiques

signes physiques ou SP : signes recherchés par les manœuvres d'examen physique.

Il faut toujours raisonner schématiquement, appareil par appareil, avec la séquence **IPPA (inspection, palpation, percussion, auscultation)**.

"Ne touchez pas le malade, notez d'abord ce que vous voyez ; développez votre sens de l'observation."

Sir William Osler (1849-1919).

développez votre sens de l'observation

- Pâleur.
- Ictère.
- Cyanose.
- Marbrures.
- Sueurs.
- Etat de vigilance.
- Attitude : prostration, tristesse, agitation...
- Etat d'hygiène.
- Degré d'autonomie : patient capable de se lever et de marcher seul ?
- Dysphonie, bruits respiratoires.
- Odeurs.

Signes généraux

Les constantes :

♦ **Poids, taille**, calcul de l'indice de masse corporelle – IMC (indice de masse corporelle) et **tour de taille** (TT, mesuré à mi-distance de la crête iliaque et des côtes inférieures) sont très importants et trop souvent oubliés. L'IMC



Calcul de l'IMC en $\text{kg/m}^2 = P/T^2$ avec P en kg et T en mètre

Signes généraux

- ◆ **PA** (pression artérielle), FC (fréquence cardiaque), température, FR (fréquence respiratoire), SpO2 (saturation en O2) et glycémie capillaire souvent réalisées.
- ◆ **BU** (bandelette urinaire) fait partie de l'examen clinique : réalisée devant toute fièvre, tout signe fonctionnel urinaire ou toute douleur abdominale.

Appareil par appareil

Au mieux, orienté selon les hypothèses diagnostiques dégagées par l'interrogatoire.

Au stade d'apprentissage pour le jeune étudiant, il est plus important de s'exercer à être systématique et à faire un examen complet.

On recherche donc, appareil par appareil, les signes physiques décrits dans chaque partie.

Revue des systèmes

- Examen cardiovasculaire.
- Examen pulmonaire.
- Examen de l'abdomen.
- Examen neurologique.
- Examen ostéoarticulaire.
- Examen uronéphrologique.
- Examen gynécologique, seins.
- Examen cutanéomuqueux et des phanères.
- Examen des aires ganglionnaires.
- Examen endocrinologique, aire thyroïdienne.
- Examen ophtalmologique.
- Examen otorhinolaryngé et stomatologique.

En cas de pathologie aigue, on commence par l'examen de la Zone d'appel.

Pour chaque système, l'examen physique se fait selon la même séquence :

- **Inspection.**
- **Palpation.**
- **Percussion.**
- **Auscultation.**

Plan de la conférence

1- Généralités :

2- Les différentes étapes de l'observation :

A- Anamnèse

B- Examen clinique orienté

C- synthèse clinique

3- Hypothèses diagnostiques

Plan de la conférence

1- Généralités :

2- Les différentes étapes de l'observation :

A- Anamnèse

B- Examen clinique orienté

C- synthèse clinique

3- Hypothèses diagnostiques

La conclusion débute par une phrase qui synthétise le problème, à partir des données recueillies à l'interrogatoire, l'examen physique.

Résumé clinique

Sexe, âge, consulte ou est hospitalisé pour : résumé avec regroupement syndromique sans recopier les informations précédentes.

Cette phrase de synthèse, très difficile à composer pour le débutant, est indispensable pour guider les examens complémentaires et proposer une stratégie de prise en charge cohérente

Plan de la conférence

1- Généralités :

2- Les différentes étapes de l'observation :

A- Anamnèse

B- Examen clinique orienté

C- synthèse clinique

3- Hypothèses diagnostiques

Toujours argumenter chaque hypothèse avec **les arguments pour** et **les arguments contre**.

Justifier logiquement de nouveau en partant de la clinique pour aller aux examens complémentaires.

Hierarchiser les hypothèses par probabilité et fréquence.

Le plan d'argumentation suivant est très utile et permet de raisonner logiquement :

TA FAC PD

Terrain, Antécédents, argument de Fréquence, Anamnèse,
Clinique, Paraclinique, Diagnostic différentiel.

- Date, identification de la personne ayant rédigé l'observation.
- Mode d'arrivée à l'hôpital, adressé par qui, coordonnées du patient et du médecin traitant.
- **Motif d'hospitalisation** (un ou plusieurs symptômes).
- **Antécédents**
 - Personnels :
 - Chirurgicaux.
 - Médicaux.
 - Allergiques.
 - Gynéco-obstétricaux (sans oublier la date des dernières règles !).
 - Familiaux (premier degré).
 - Traitements habituels ou occasionnels.
- **Mode de vie**
 - Contexte socioprofessionnel.
 - Contexte familial, marital, vie affective.
 - Eventuelles intoxications.
 - Voyages, animaux de compagnie.

- **Histoire de la maladie**

- Localisation des troubles.
- Début :
 - Quand (date, heure) ?
 - Occupation lors de la survenue des troubles.
 - Mode d'installation, facteur déclenchant.
- Rythme, durée.
- Qualité des troubles.
- Intensité, sévérité, retentissement sur le quotidien.
- Facteurs qui aggravent et soulagent.
- Manifestations associées.

- **Examen clinique**

- Poids et signes vitaux.
- Apparence générale.
- Recherche des signes physiques (inspection, palpation, percussion, auscultation) :
 - Cardio-vasculaire.
 - Pleuro-pulmonaire.
 - Abdomen.
 - Neurologique.
 - Locomoteur.
 - Uro-génital.
 - Seins.
 - Aires ganglionnaires.
 - Cutanéomuqueux.
 - Tête et cou.
- Nez, bouche, gorge, oreilles, yeux
- Thyroïde
- Examen pelvien

- **Conclusion**

- Synthétiser le problème en une courte phrase.
- Liste des hypothèses diagnostiques par ordre de vraisemblance.
- Ebaucher une stratégie de prise en charge.